

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

**Alefacept(유전자재조합,
숙주:BNM106 CHO 벡터:pMDF(92)Ig-3) 15mg
(아메비브주 15mg, (주)엘지생명과학)**

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 바이알 중 alefacept(유전자재조합, 숙주:BNM106 CHO 벡터:pMDF(92)Ig-3) 15mg

☐ **효능 효과 :**

- 전신요법이나 광선요법이 필요한 성인의 중등도 및 중증 만성판상건선의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2012년 제2차 약제급여평가위원회 : 2012년 1월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2011년 11월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “전신요법이나 광선요법이 필요한 성인의 중등도 및 중증 만성판상건선의 치료”에 허가받은 새로운 약물작용 기전의 약제로 치료 선택의 폭을 넓힐 수 있으나, 대체약제와 직접비교임상시험은 없고 메타분석 등에서 PASI 75 반응을 비교한 결과 유효성이 가장 낮으며, 투약비용 비교 결과 대체약제 가중평균가 대비 고가 또는 유사하여 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “전신요법이나 광선요법이 필요한 성인의 중등도 및 중증 만성판상건선의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 etanercept, adalimumab, infliximab이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 사람 LFA-3(leukocyte function-associated 3)와 면역글로불린 IgG Fc region으로 구성된 fusion protein으로, 새로운 기전의 약제임¹⁾.
- 중등도-중증의 만성 판상건선 치료에서, 신청품은 다른 생물학적 제제와 동일한 치료위치로 추천되거나²⁾³⁾, 초기 반응이 늦게 나타나므로 First choice로 추천되지 않음⁴⁾.
- 중등도-중증의 만성 판상건선 환자 대상, 위약대조 3상 임상시험으로 12주 투여 후 (10mg: 173명, 15mg: 166명, 위약: 168명) 12주간 추적 관찰한 결과, 시험기간(24주) 동안 PASI가 75%이상 감소한 환자비율이 신청품 15mg에서 위약보다 높음(15mg: 33%, 위약:13%, $p<0.001$)⁵⁾.
 - 신청품 마지막 투여 2주 후(14주째) PASI 75%이상 감소한 환자비율이 신청품에 유의하게 높음(15mg: 21%, 위약:5%, $p<0.001$)⁶⁾.
- 3상 임상시험 환자를 대상으로 한 extension연구로서 신청품 15mg(n=131) 12주 투여 후 12주간 추적 관찰한 결과 시험기간 동안(24주) PASI 75%이상 감소한 환자비율이 43%임⁷⁾.
 - 3상 임상시험에서 시험기간 동안 PASI 75%이상 감소한 환자(n=54)대상으로 off-treatment 반응기간에 PASI 50이 지속된 기간(중앙값)은 209일(약 7개월)임.

- 중등도-중증의 건선치료제인 생물학적 제제(alefacept, etanercept, infliximab)의 RCT 메타분석 결과, 10-14주째 PASI 75의 위약대비 효과는 infliximab > etanercept > alefacept 순위이며⁸⁾, 장기효과 비교시 TNF- α 및 ustekinumab에 비해 효과가 떨어지는 것으로 보임⁹⁾.
- 신청품은 부작용 검증 기간이 짧고 지속성이 길어 조절이 용이하지 않으므로 생물학적 제제 중 2차로 선택될 수 있으며¹⁰⁾, 임상연구문헌 등을 참조하여 비교 대상약제인 TNF- α inhibitors에 비해 치료 효과가 떨어져 임상적으로 유용성이 적을 것으로 판단되나, 동 약제가 새로운 기전의 건선치료제라는 점에서 기존의 TNF- α inhibitors 사용 후 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우에 한해 사용이 가능할 것으로 사료됨¹¹⁾.
- 신청품은 허가사항에 따라 투약을 시작하기 전과 12주 투약요법을 하는 과정동안 매 2주마다 CD4+ T 림프구 수를 측정하여야 하며, 한달동안 250cells/uL 이하로 유지되는 경우 투약을 중지함¹²⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “전신요법이나 광선요법이 필요한 성인의 중등도 및 중증 만성판상건선의 치료”에 허가받은 약제로, 임상진료 지침¹³⁾, 급여기준(안)¹⁴⁾, 학회의견¹⁵⁾ 등을 고려할 때, “etanercept, adalimumab, infliximab”을 대체약제로 선정함.
- 생물학적 제제(etanercept, infliximab, alefacept)의 메타분석 결과 신청품의 효과는 가장 낮았으며 장기 효과¹⁶⁾¹⁷⁾에 대한 review 결과 신청품은 투여하는 동안 타 생물학적 제제 대비 효과가 낮고, CD4+ T세포 모니터링 등 투여의 편의성 면에서 어려움이 있으나, 신청품의 투약비용은 ■■■원¹⁸⁾으로 대체약제 가중평균가¹⁹⁾(36주 기준: ■■■원, 48주 기준: ■■■원)대비 고가 또는 유사하므로 비용효과성이 불분명함.

○ 재정 영향²⁰⁾

- ■■■ 대상 환자수를 기준으로 급여기준(안)에 따른 대상 환자수는 1차년도 ■■■명, 3차년도 ■■■명으로 예측됨²¹⁾. 급여기준(안)에 따른 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원임.
 - TNF- α 길항제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우의 비율 및 제약사 시장 점유율에 따라 재정이 증가될 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 약가가 등재되어 있음.

Reference

- 1) PDR, 2011. : T 세포의 CD2 수용체에 결합하여 T 세포 활성화의 상호촉진단계(co-stimulation step)를 차단하여 건선 T 세포의 활성화를 억제하며 effector memory T 세포를 감소시켜 T 세포 apoptosis를 유도하여 Pathogenic T cell을 제거함.
- 2) 2008 AAD(American Academy of Dermatology). Guideline of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis-section 1. overview of psoriasis and guidelines of care for the treatment of psoriasis with biologics.
- 3) 2010 AAD(American Academy of Dermatology). Guideline of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis- section1, section6.
- 4) European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2009.10.
- 5) Mark Lebwohl et al. An international randomized, double-blind, placebo-controlled phase3 trial of intramuscular alefacept in patients with chronic plaque psoriasis. Arch Dermatol. 2003 Jun;139(6):719-27.
- 6) J-P Ortonne. Clinical response to alefacept : results of a phase 3 study of intramuscular administration of alefacept in patients with chronic plaque psoriasis. 2003 European Academy of Dermatology and Venereology 17(Suppl.2), 12-16.
- 7) Kenneth B gordon et al. Remittive effects of intramuscular alefacept in psoriasis. Journal of Drugs in dermatology 2003;2(6):624-628
- 8) A.K. Brimhall et al. Safety and efficacy of alefacept, efalizumab, etanercept and infliximab in treating moderate to severe plaque psoriasis: a meta-analysis of randomized controlled trials. British journal of dermatology 2008 159, pp274-285
- 9) Alwawi et al. Long term efficacy of biologics in the treatment of psoriasis : what do we really know? Dermatologic therapy Vol 22,2009,431-440.
- 10) 대한피부과학회 의견, [REDACTED]
- 11) 중앙심사평가조정위원회 - 2011.11.14
- 12) 아메비브주 식약청 허가사항 - [REDACTED]
- 13) European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2009.10.
- 14) 중앙심사평가조정위원회 - 2011.11.14
- 15) 대한피부과학회 의견, [REDACTED]
- 16) Alwawi et al. Long term efficacy of biologics in the treatment of psoriasis : what do we really know? Dermatologic therapy Vol 22,2009,431-440. [REDACTED]
- 17) Alan Menter et al, The efficacy of multiple courses of alefacept in patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2006;54:61-3.
- 18) [REDACTED].
- 19) 36주는 신청품의 2주기까지 투약기간에 해당하며, 48주는 2주기 째 투약 후 휴약기간 12주를 포함하는 경우임.
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) EDI 청구 환자수 : 상병코드 [REDACTED]으로 etanercept, adalimumab, infliximab 약제를 청구한 18세 이상 환자 중, [REDACTED]를 더함.
- 22) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]바이알, 2차년도 [REDACTED]바이알, 3차년도 [REDACTED]바이알), 제약사 시장 점유율(2012년: [REDACTED], 2013년 [REDACTED], 2014년 [REDACTED])
- 23) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 x 신청가